Clínica Motion Fisio

Informe de análisis biomecánico por vídeo
14 de octubre de 2026

Paciente Prueba

31 años · mujer · 165 cm · Prueba con vídeo real

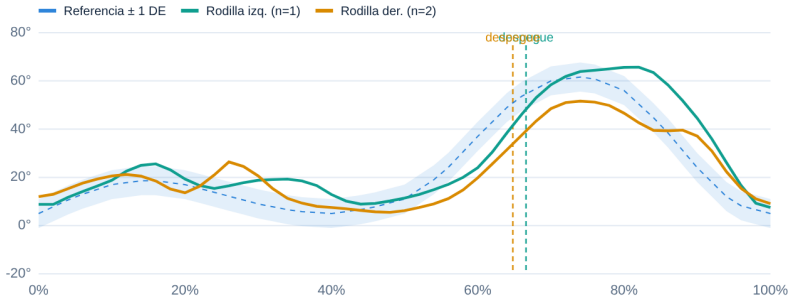
Marcha · Sesión 1 de 1 · Vista lateral
Calidad de captura 93 % · 3 zancadas

VELOCIDAD DE MARCHA	ESTADO	VS. SESIÓN ANTERIOR	VS. PRIMERA SESIÓN
1,26 ± 0,03 m/s	**Revisar**	–	–



Fotograma de máxima flexión de rodilla

Flexión de rodilla en el ciclo de marcha (grados)



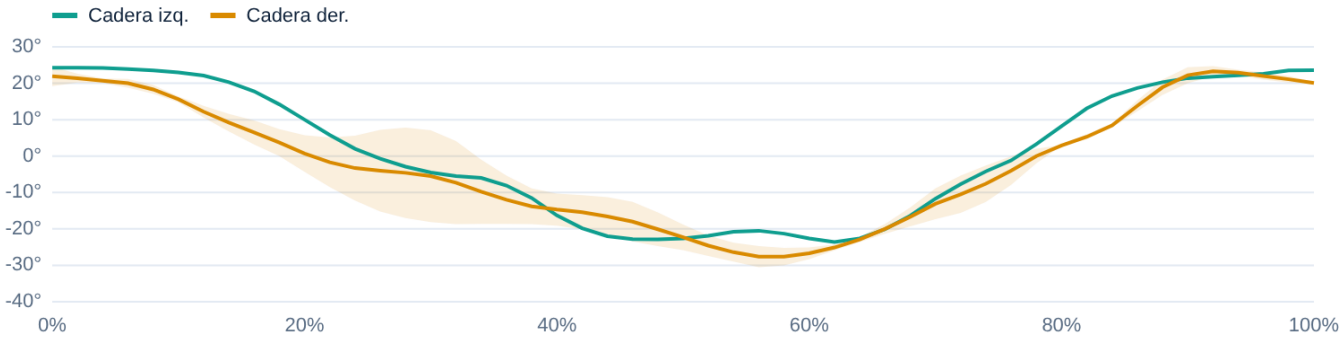
Media de todos los ciclos por lado frente a la curva de referencia (Winter, 2009; Kadaba et al., 1990). Líneas verticales: despegue medio.

Resultados

Parámetro	Media ± DE	n	Referencia	Valoración	Fiab.
ESPACIOTEMPORALES					
Velocidad de marcha	**1,26 ± 0,03 m/s**	3	>= 1,14 m/s (media 1,34 para edad y sexo - 15 %)	En rango	Media
Cadencia	**98 ± 1 pasos/min**	3	95–125	En rango	Media
Longitud de zancada	**1,54 ± 0,04 m**	3	0,72–0,92 × talla	Alto	Media
Duración de la zancada	**1,22 ± 0,01 s**	3	0,95–1,25 s	En rango	Media
Fase de apoyo izq.	**66,6%**	1	57–64 %	Alto	Baja
Fase de apoyo der.	**64,8 ± 0,3%**	2	57–64 %	Alto	Media
Doble apoyo	**31,9 ± 0,8%**	3	16–26 %	Alto	Media
SIMETRÍA Y VARIABILIDAD					
Variabilidad de la zancada (CV)	**0,8%**	3	< 3 %	En rango	Baja
Asimetría del tiempo de paso (IS)	**8,3%**	1	< 10 %	En rango	Baja
Asimetría de la fase de apoyo (IS)	**2,6%**	1	< 10 %	En rango	Baja
Asimetría de la longitud de paso (IS)	**13,3%**	1	< 10 %	Alto	Baja
Asimetría de la flexión de rodilla en oscilación (IS)	**24,1%**	1	< 10 %	Alto	Baja
CINEMÁTICA SAGITAL					
Rodilla izq.: flexión máx. en oscilación	**66°**	1	55–70°	En rango	Baja
Rodilla izq.: flexión en respuesta a la carga	**26°**	1	10–25°	Alto	Baja
Rodilla izq.: flexión en el contacto inicial	**9°**	1	0–10°	En rango	Baja
Rodilla izq.: desviación de la curva normal (GVS)	**9°**	1	< 8° (orientativo)	Alto	Baja
Cadera izq.: rango sagital	**48°**	1	35–50°	En rango	Baja
Rodilla der.: flexión máx. en oscilación	**52 ± 2°**	2	55–70°	Bajo	Media
Rodilla der.: flexión en respuesta a la carga	**26 ± 10°**	2	10–25°	Alto	Media
Rodilla der.: flexión en el contacto inicial	**12 ± 4°**	2	0–10°	Alto	Media
Rodilla der.: desviación de la curva normal (GVS)	**9°**	2	< 8° (orientativo)	Alto	Media
Cadera der.: rango sagital	**52 ± 2°**	2	35–50°	Alto	Alta
Inclinación del tronco (media)	**-9°**				Alta

Fiabilidad: alta = vista adecuada, buena visibilidad y suficientes ciclos o repeticiones; media = pocos ciclos, vista oblicua o variable sensible al error 2D; baja = orientativo, no genera alertas.

Flexión de cadera en el ciclo (± 1 DE entre ciclos)



Puntos a revisar

• Longitud de zancada: 1,54 m ± 0,04 (referencia 0,72–0,92 × talla; fiabilidad media).
• Fase de apoyo der.: 64,8% ± 0,3 (referencia 57–64 %; fiabilidad media).
• Doble apoyo: 31,9% ± 0,8 (referencia 16–26 %; fiabilidad media).
• Rodilla der.: flexión máx. en oscilación: 52° ± 2 (referencia 55–70°; fiabilidad media).
• Rodilla der.: flexión en respuesta a la carga: 26° ± 10 (referencia 10–25°; fiabilidad media).
• Rodilla der.: flexión en el contacto inicial: 12° ± 4 (referencia 0–10°; fiabilidad media).
• Rodilla der.: desviación de la curva normal (GVS): 9° (referencia < 8° (orientativo); fiabilidad media).
• Cadera der.: rango sagital: 52° ± 2 (referencia 35–50°).

Valoración profesional

Se han analizado 3 zancadas (1 izq., 2 der.). Velocidad de marcha 1.26 m/s ± 0.03, cadencia 98 pasos/min ± 1. Flexión máxima de rodilla en oscilación: 66° (izq.) y 52° ± 2 (der.). Fuera del rango de referencia: longitud de zancada; fase de apoyo der.; doble apoyo; rodilla der.: flexión máx. en oscilación; rodilla der.: flexión en respuesta a la carga; rodilla der.: flexión en el contacto inicial; rodilla der.: desviación de la curva normal (gvs); cadera der.: rango sagital. Valores obtenidos por visión artificial 2D; deben interpretarse según el criterio del fisioterapeuta.

Método y calidad de la medición

Vista lateral (índice 0,15) · persona detectada en el 84 % de 138 fotogramas · visibilidad media 97 % · 30 Hz · duración 4,6 s · 2 correcciones izq./der..

• Estimación de pose 2D con MediaPipe BlazePose (33 puntos; Bazarevsky et al., 2020), modelo Full.
• Remuestreo uniforme a 30 Hz; puntos con visibilidad < 0,5 descartados y huecos <= 0,25 s interpolados linealmente.
• Corrección de intercambios izquierda/derecha por continuidad temporal (2 fotogramas corregidos).
• Filtro Butterworth paso bajo de 2º orden en doble pasada (fase cero, 4º orden efectivo), frecuencia de corte 6 Hz con la corrección de Winter (2009).
• Cada métrica se expresa como media ± desviación estándar entre ciclos, repeticiones o ventanas (n). Un cambio entre sesiones se considera real cuando es estadísticamente significativo (t de Welch, p < 0,05; Welch, 1947) y además supera el cambio mínimo relevante de esa métrica (p. ej., 0,10 m/s en velocidad; Perera et al., 2006).
• Eventos de la marcha por el método de coordenadas de Zeni et al. (2008): contacto inicial = máxima posición anterior del talón respecto a la pelvis; despegue = mínima posición del antepié. Solo se usan tramos de marcha en una dirección (se excluyen giros y paradas).
• Ángulos normalizados al 0–100 % del ciclo (51 puntos) y promediados por lado. La desviación respecto a la curva de referencia se expresa como Gait Variable Score (raíz del error cuadrático medio; Baker et al., 2009).
• Simetría mediante el índice de Robinson et al. (1987): IS = |D - I| / (0,5·(D + I)) × 100. Variabilidad como coeficiente de variación de la duración de la zancada (Hausdorff, 2005).
• Escala espacial a partir de la talla: distancia hombro–tobillo ~ 0,779 × talla (Drillis y Contini, 1966). Supone cámara fija y perpendicular a la dirección de la marcha.

Referencias

1. Bazarevsky V, Grishchenko I, Raveendran K, et al. BlazePose: On-device real-time body pose tracking. arXiv:2006.10204; 2020.
2. Winter DA. Biomechanics and Motor Control of Human Movement. 4ª ed. Hoboken: Wiley; 2009.
3. Zeni JA, Richards JG, Higginson JS. Two simple methods for determining gait events during treadmill and overground walking using kinematic data. Gait Posture. 2008;27(4):710-4.
4. Baker R, McGinley JL, Schwartz MH, et al. The Gait Profile Score and Movement Analysis Profile. Gait Posture. 2009;30(3):265-9.
5. Robinson RO, Herzog W, Nigg BM. Use of force platform variables to quantify the effects of chiropractic manipulation on gait symmetry. J Manipulative Physiol Ther. 1987;10(4):172-6.
6. Hausdorff JM. Gait variability: methods, modeling and meaning. J Neuroeng Rehabil. 2005;2:19.
7. Perry J, Burnfield JM. Gait Analysis: Normal and Pathological Function. 2ª ed. Thorofare: SLACK; 2010.
8. Kadaba MP, Ramakrishnan HK, Wootten ME. Measurement of lower extremity kinematics during level walking. J Orthop Res. 1990;8(3):383-92.
9. Bohannon RW, Williams Andrews A. Normal walking speed: a descriptive meta-analysis. Physiotherapy. 2011;97(3):182-9.
10. Fritz S, Lusardi M. White paper: "Walking speed: the sixth vital sign". J Geriatr Phys Ther. 2009;32(2):46-9.
11. Drillis R, Contini R. Body segment parameters. Technical Report 1166-03. New York University; 1966.
12. Welch BL. The generalization of "Student's" problem when several different population variances are involved. Biometrika. 1947;34(1-2):28-35.
13. Perera S, Mody SH, Woodman RC, Studenski SA. Meaningful change and responsiveness in common physical performance measures in older adults. J Am Geriatr Soc. 2006;54(5):743-9.